

Dekubitusprophylaxe

Risiko erkennen, Haut schützen, Maßnahmen begründen – kompakt nach DNQP und NPIAP/EPUAP

Braden-Skala

Lagerung

Hautinspektion

Kategorien 1–4

Ernährung

≤ 18

Braden: Risiko

≤ 12

Braden: hohes Risiko

4 + 2

Kategorien 1–4 plus nicht
klassifizierbar und
Verdacht auf DTI

2 h

Lagerungswechsel oder
individueller Plan

Lernunterlage, kein Ersatz für die hausinterne Standardarbeitsanweisung oder ärztliche Anordnung. Vor Anwendung im Dienst Haus-Standards und den DNQP-Expertenstandard (2017) prüfen. Herausgeber: PLAN NRW · Patrick Schenkelberger · Bochum.

Was ist ein Dekubitus?

Ein Dekubitus ist eine lokal begrenzte Schädigung von Haut und/oder darunterliegendem Gewebe, meist über knöchernen Vorsprüngen. Hauptursachen sind Druck und Scherkräfte, verstärkt durch Feuchtigkeit und Reibung. Die Schädigung entsteht oft unbemerkt von innen nach außen.

Risikoeinschätzung

Vor jeder Maßnahme steht ein strukturiertes Assessment. Standard ist die **Braden-Skala** (max. 23 Punkte, je niedriger, desto höher das Risiko). Bereiche: sensorisches Empfindungsvermögen, Feuchtigkeit, Aktivität, Mobilität, Ernährung, Reibung und Scherkräfte.

≤ 18	Dekubitusrisiko
≤ 12	hohes Risiko
≤ 9	sehr hohes Risiko

Regel: Assessment bei Aufnahme und bei jeder Veränderung wiederholen. Ergebnis dokumentieren.

Risikofaktoren

Mobilität	eingeschränkt, bettlägerig, Immobilität
Wahrnehmung	Sensibilitätsstörung, Bewusstseinsänderung
Feuchtigkeit	Inkontinenz, Schwitzen, Wundexsudat
Ernährung	Mangelernährung, Flüssigkeitsdefizit, Gewichtsverlust
Scherkräfte	Rutschen im Bett, falsche Hochlagerung des Kopfteils
Allgemein	Fieber, Durchblutungsstörungen, Begleiterkrankungen

Prophylaxe-Maßnahmen

Lagerung	Lagerungswechsel alle 2 Stunden oder nach individuellem Plan. Druckentlastung von Fersen, Steißbein und Schulterblättern. Antidekubitusmatratze bzw. Wechseldruckmatratze nach Risiko.
Scherkräfte	Kopfteil möglichst niedrig halten. Patient beim Umlagern anheben statt schieben. Rutschen aktiv verhindern.
Hautbeobachtung	Bei jeder Pflegehandlung prüfen. Fingertest: Rötung, die nicht wegdrückbar ist, entspricht Kategorie 1. Prädilektionsstellen: Sakrum/ Steißbein, Fersen, Trochanter, Sitzbein, Ellenbogen, Hinterkopf.
Hautpflege	pH-neutral pflegen, Haut trocken und sauber halten. Keine Massage bei Rötung. Inkontinenzversorgung optimieren.
Hilfsmittel	Druckverteilende Auflagen und Matratzen nach Risiko. Fersenschutz bei Bettlägerigkeit. Keine Ringe oder Rollen unter den Fersen.
Mobilisation	Aktivierung und Bewegung fördern, so weit möglich. Sitzdauer im Stuhl begrenzen und Druckentlastung einplanen.
Ernährung	Proteinreiche Kost, Flüssigkeit mindestens 1,5–2 l/Tag. Ernährungsstatus erfassen, bei Mangelernährung ärztlich abklären. Sondenernährung allein zur Prävention wird laut Leitlinie 2025 nicht empfohlen.
Dokumentation	Risiko, Maßnahmen, Hautbefund und Wirkung lückenlos festhalten.

Kategorien (EPUAP/NPIAP/PPPIA)

Kategorie 1	nicht wegdrückbare Rötung, Haut intakt
Kategorie 2	Teilverlust der Haut, offene Blase oder Abschürfung
Kategorie 3	vollständiger Hautverlust, Subkutis sichtbar, kein Knochen
Kategorie 4	vollständiger Gewebeerlust, Knochen, Sehnen oder Muskel betroffen
Nicht klassifizierbar	Wundgrund durch Beläge (Nekrose, Fibrin) verdeckt. Tiefe nicht beurteilbar
Verdacht auf DTI	lokal begrenzt, intakte Haut, dunkelrot bis violett oder blutgefüllte Blase. Schmerz und Temperaturunterschied können vorausgehen

Achtung: Bereits bei Kategorie 1 die Prophylaxe intensivieren. Bei Verdacht auf DTI die Stelle nicht massieren, Druck sofort entlasten und den Verlauf engmaschig kontrollieren, da sich der Schaden oft erst zeigt, wenn er fortgeschritten ist. Ärztliche Information und Wundversorgung nach Haus-Standard.

Quellen zur Prüfung: DNQP-Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege (2017). EPUAP/NPIAP/PPPIA-Leitlinie 2019 (Klassifikation); Aktualisierung 2025 als Living Guideline, Stand 10/2026 prüfen.